

GUIÓN DE SPEECH — DIAPOSITIVAS 2, 3, 4 Y 5 (numeración corregida)

Marco Teórico: Timeline del self · Qué medimos · Las cuatro caras del bienestar · Justificación

Duración estimada: 6–8 minutos

CÓMO LEER ESTE GUIÓN

- [DIAPOSITIVA X] = momento exacto en que cambias de slide
 - (*pausa*) = espera 1-2 segundos para que el tribunal lea la diapositiva
 - **Negrita** = énfasis oral
 - *Cursiva* = término técnico o dato concreto, pronúncialo con precisión
-

[DIAPOSITIVA 2 — "Un siglo de estudio del self"]

(pausa breve — deja que vean la línea temporal)

Para entender qué mide este trabajo y por qué tiene sentido medirlo junto, necesito situaros primero en el debate teórico que lleva más de ciento treinta años abierto en psicología: ¿qué somos cuando decimos "yo" +/-

Todo empieza con **William James** en 1890. James fue el primero en dividir el self en dos: el *I* —el yo que piensa y actúa— y el *Me* —el yo como objeto de conocimiento, lo que uno sabe de sí mismo. Ya entonces intuye que el self es **multidimensional**: tiene una cara material, una social y una espiritual.

Doce años después, en 1902, **Cooley** introduce una idea que tiene consecuencias clínicas directas: el **yo-espejo**. Nos vemos a nosotros mismos como creemos que nos ven los demás. No es cómo nos ven realmente; es nuestra percepción de esa mirada. Esto explica por qué en pacientes que han vivido rechazo, estigma o violencia, la imagen de uno mismo puede estar severamente distorsionada aunque los logros objetivos sean altos.

En 1934, **Mead** radicaliza esta idea: el self no existe antes de la interacción social, **se construye en ella**. Internalizamos las expectativas del grupo al que pertenecemos, y eso moldea quiénes creemos ser. Esta dimensión social del autoconcepto es central para entender por qué los trastornos clínicos que implican estigma —obesidad, disforia de género, conducta suicida— afectan tan profundamente a la imagen de uno mismo.

En 1965, **Rosenberg** da el salto instrumental: crea la escala RSES —diez ítems, cuatro puntos, libre acceso, validada en más de cincuenta culturas— que convierte la autoestima en algo medible de forma sistemática. Sigue siendo el gold standard mundial y el instrumento más frecuente en el corpus de mi trabajo.

En 1976, **Shavelson** y colaboradores proponen que el autoconcepto no es un número único sino una **arquitectura jerárquica**: en la cúspide, un autoconcepto general; debajo, el académico y el no académico; en la base, subdimensiones específicas —físico, social, emocional. Esto es clave: una persona puede tener un autoconcepto físico muy negativo y uno académico muy positivo. Si solo mides la

autoestima global, te pierdes esa especificidad clínica.

Y llegamos a 2003, con el meta-análisis de **Baumeister**, que revisó toda la evidencia causal sobre la autoestima. Su conclusión fue incómoda: los efectos causales son más modestos de lo que el campo había afirmado. Esto no invalida la autoestima como constructo, pero sí exige más rigor. Es precisamente la pregunta que este trabajo intenta responder con mayor precisión: ¿cuánto, en qué condiciones y en qué poblaciones predice la autoestima el bienestar+/-

Y aquí es donde entra la nota que aparece en la parte inferior de esta diapositiva: las **falacias jingle y jangle**. La falacia jingle consiste en usar el mismo nombre para dos constructos distintos —por ejemplo, llamar "autoestima" a la valoración global y al autoconcepto físico, que son cosas distintas. La falacia jangle es la contraria: usar términos distintos para lo mismo. Estas falacias han contaminado décadas de literatura y hacen casi imposible acumular conocimiento de forma coherente. Por eso este trabajo trata autoestima y autoconcepto de forma diferenciada, no como sinónimos.

[DIAPOSITIVA 3 — "Qué medimos exactamente"]

(pausa)

Una vez situado el debate teórico, la pregunta es: ¿con qué instrumentos operacionalizamos estos constructos+/-

La diapositiva muestra los tres bloques de variables del trabajo.

El primer bloque es la **autoestima**: evaluativa y global, responde a la pregunta "¿cuánto me valoro+/-". Es la dimensión afectiva del self. Se mide principalmente con la **Rosenberg Self-Esteem Scale** —diez ítems, Likert de cuatro puntos— que es el instrumento más frecuente en el corpus.

El segundo bloque es el **autoconcepto**: descriptivo y multidimensional, responde a "¿cómo me veo en distintos ámbitos+/-". Incluye dominios académico, social, físico y corporal. Se mide con el **Self-Description Questionnaire** de Marsh y, cuando el foco es el cuerpo específicamente, con el *Physical Self-Description Questionnaire*. Este segundo instrumento es el que aparece más en los bloques de obesidad pediátrica y trastornos de imagen corporal.

El tercer bloque es el **bienestar**, que es la variable resultado. Incluye medidas de calidad de vida relacionada con la salud —HRQoL— e indicadores de salud mental general. Lo detallo en la siguiente diapositiva.

Un apunte importante: la heterogeneidad de instrumentos entre meta-análisis es uno de los desafíos metodológicos centrales de esta revisión. No todos usan la RSES; no todos usan el mismo instrumento de bienestar. Eso dificulta una síntesis cuantitativa global y es la razón por la que organizo los resultados por bloques temáticos homogéneos, no en un único número agregado.

[DIAPOSITIVA 4 — "El bienestar tiene cuatro caras"]

(pausa — señala cada uno de los cuatro bloques)

El bienestar es la variable resultado de todo el trabajo, y es fundamental que quedemos alineados en que **no es un constructo unitario**. Hay cuatro tradiciones teóricas que lo definen de manera distinta, y los meta-análisis del corpus las usan de forma no siempre equivalente.

La primera es el **bienestar subjetivo o hedónico**, conceptualizado por **Diener**. Para Diener, estar bien es tener más emociones positivas que negativas —el balance afectivo— más la satisfacción global con la propia vida. Se mide con la Satisfaction With Life Scale o el PANAS. Es la tradición más usada en psicología social y positiva, pero puede capturar bienestar superficial: alguien puede sentirse bien a corto plazo sin estar realmente floreciendo.

La segunda es el **bienestar psicológico o eudaimónico**, de **Ryff**, con raíces aristotélicas. El bienestar no es sentirse bien sino **vivir bien**, desarrollarse. Ryff propone seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. Las dos que más se solapan con autoestima y autoconcepto son la **autoaceptación** y el **propósito en la vida**. Este modelo aparece poco en el corpus clínico, y eso en sí mismo es un hallazgo: la psicología clínica ha estado más centrada en eliminar el malestar que en promover el florecimiento. Es una laguna que señalo explícitamente en la discusión.

La tercera es la **calidad de vida relacionada con la salud**, la HRQoL. Es la medida predominante en contextos médicos porque evalúa el impacto percibido de la condición de salud en el funcionamiento físico, psicológico y social. Se operacionaliza con el SF-36, el EQ-5D o el **WHOQOL-BREF** de la OMS. Es el tipo de medida más frecuente en los bloques de salud somática y obesidad pediátrica.

Y la cuarta es la **salud mental general**, conceptualizada por **Keyes**. Keyes propone que ausencia de enfermedad mental no equivale a salud mental. Son dos continuos independientes: puedes tener un diagnóstico y aun así tener alta salud mental positiva —lo que Keyes llama *flourishing*—, o puedes no tener ningún diagnóstico pero estar en *languishing*, sin recursos reales de bienestar. Esta distinción me parece especialmente relevante para el psicólogo sanitario, cuyo objetivo no debería ser solo reducir síntomas, sino también construir recursos positivos en el paciente.

[DIAPOSITIVA 5 — "Evidencia abundante... pero fragmentada"]

(pausa)

Con el marco teórico situado, llegamos a la pregunta que justifica este trabajo: si ya hay tanta investigación sobre autoestima y bienestar, ¿por qué una revisión más+/-

La respuesta tiene dos partes, que aparecen en esta diapositiva.

La primera es que la evidencia existente es **abundante pero fragmentada**. Es una de las literaturas más voluminosas de toda la psicología. La síntesis más ambiciosa hasta la fecha es la de **Zell y Johansson**, del año 2025, que agrega cuarenta meta-análisis y obtiene una correlación global de $r = .31$. Para la salud mental, sube hasta $r = .42$; para la salud física, baja a $r = .15$. Son datos útiles, pero tienen un problema fundamental: **mezclan población clínica y no clínica**, lo que puede enmascarar efectos específicamente relevantes para la práctica clínica. Y cada meta-análisis que sintetizan aborda solo una porción del problema —suicidalidad, o obesidad, o imagen corporal—, lo que da una visión fragmentada difícil de transferir a la clínica.

La segunda parte es el hueco concreto que cubre este TFM:

Primero, restrinjo la muestra a población clínica: al menos el 75% de los participantes de cada meta-análisis debe tener un diagnóstico o condición clínica. Esto permite responder a una pregunta más específica y más útil para quien trabaja en contextos sanitarios.

Segundo, integro tanto autoestima como autoconcepto —incluida la imagen corporal— como dos caras del mismo objeto. No colapso todo en un único número, sino que diferencio constructos y exploro qué dimensión del bienestar predice cada uno en cada población.

Y aquí va el argumento clínico central: **las intervenciones se diseñan sobre constructos específicos**, no sobre un agregado global. Si quiero intervenir en la imagen corporal de un adolescente con obesidad, necesito saber si el autoconcepto físico predice su bienestar más que la autoestima global. Esa especificidad es lo que este trabajo intenta proporcionar.

(Pausa natural antes de pasar a la siguiente slide)

Con la justificación clara, paso a los objetivos concretos del trabajo.

[FIN DEL GUIÓN — DIAPOSITIVAS 2 A 5]

Tiempo estimado: 6–8 minutos